06

S.P 4750

38

مدققة 07/10/2024

مُقدمة في الأعراض والأمراض الرثوية

1 د. مهند أبو كرشة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

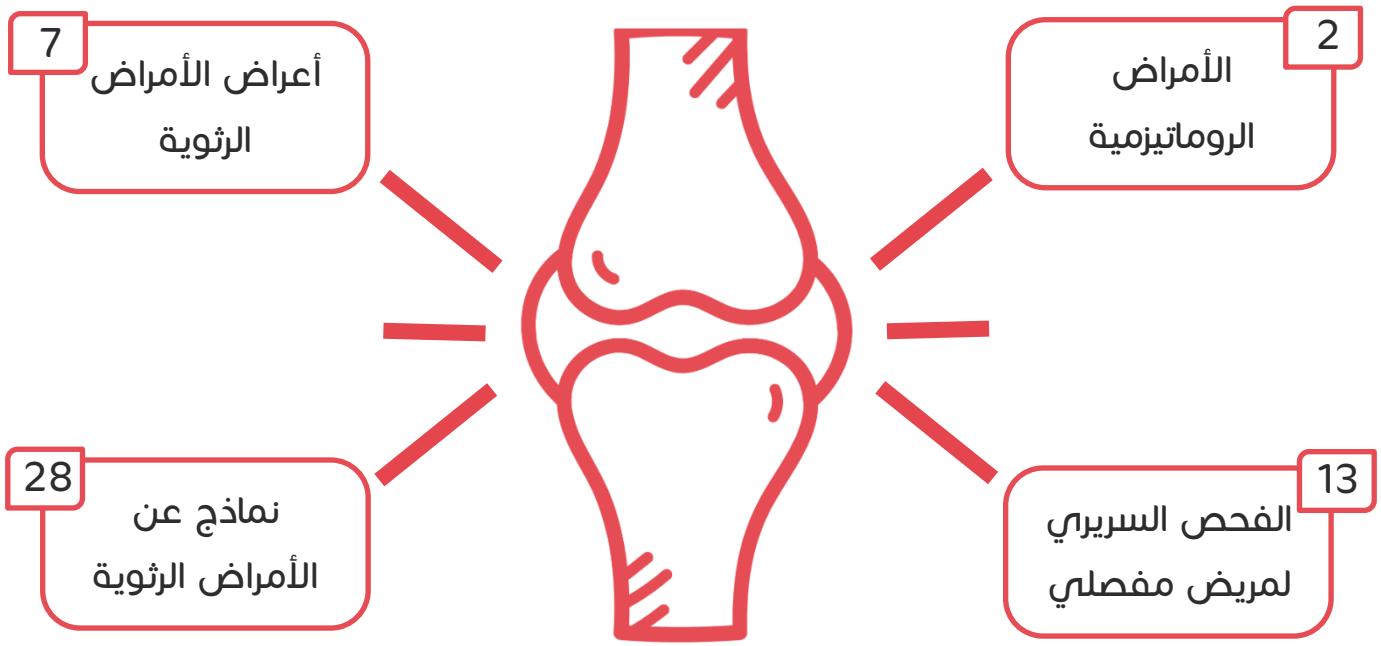
RBO Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

نبدأ معكم رحلتنا في المحاضرة الأولى لقسم الرثوية من مادتنا الممتعة المهارات السريرية، إذ نعرفكم بداية على علم الأمراض الرثوية وكيفية أخذ القصة السريرية مع الفحص السريري، مع عرض بعض نماذج الأمراض الرثوية والأعراض التي ترافقها

ونتمنى أن نكون قد وفقنا في طرحها بالشكل الأمثل





الأمراض الروماتيزمية (الرثوية) Rheumatology

- يتضمن علم الأمراض الرثوية أمراض المفاصل والأوتار والعضلات والغضاريف والأربطة.
- وقد استُخدم مصطلح Rheumatology للإشارة إلى الأمراض التي تنتشر في أجهزة الجسم كافة لتستقر أخيراً في المفاصل مسببةً التهابات المفاصل Arthritis.
- ومنه نستنتج أن الأمراض المفصليّة يمكن أن تكون عَرَض لمرض جهازي عام (فبعض الأمراض الجهازيّة لها انعكاسات مفصليّة).

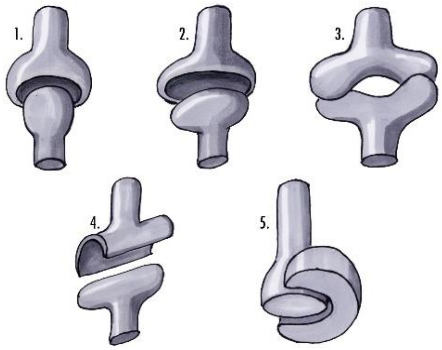
التسميات المختلفة للأمراض الرثوية:

- ✓ الأمراض المفصليّة الجهازية Systemic articular Diseases.
- ✓ أمراض المناعة الذاتية [1] Autoimmune diseases.
- ✓ أمراض النسيج الضام Connective tissue disease: لأنها تصيب الأنسجة الداعمة والبرانشيمية في الأعضاء المختلفة.

لنبدأ أولاً تذكرة عن نماذج المفاصل

للمفاصل ثلاث أنواع:

- ✓ **المفاصل الثابتة (الليفية):** مثل الدروز في الجمجمة.
- ✓ **المفاصل نصف المتحركة (الغضروفية):** كما في العمود الفقري.
- ✓ **المفاصل المتحركة (الزليلية):** ولها أنواع حسب شكل السطح العظمي منها:



لاحظ أشكال المفاصل الزليلية بالترتيب (كروي، لقمي، سرجي، بكري، أسطواني)

1. **المفاصل الكروية:** وهي عبارة عن سطح محدب موجود في جوف مقعر، تتحرك على 3 محاور متعامدة ولها حركات واسعة، مثل الكتف والورك (العطف – البسط التقريب – التبعيد – الدوران للوحشي – الدوران للأنسي- الحركات الدورانية).
2. **المفاصل اللقميّة:** مثل مفصل المعصم والكاحل، يتحركان على محورين متعامدين (عطف – بسط – إلى اليمين – إلى اليسار).
3. **المفاصل السرجية:** مثل المفصل الرسغي السنعي للإبهام.
4. **المفصل البكري:** مثل مفصل المرفق والركبة (بسط وعطف في محور واحد).
5. **المفاصل الاسطوانيّة:** بين الزند والكعبرة وتكون الحركة محدودة مثل الكب والاستلقاء.

شكل المفصل هو الذي يحدد سعة الحركة ومجال الحركة.

[1] استناداً لأهميته المرضية.

كيفية أخذ القصة السريرية من المريض The Clinical History

☒ لا يختلف المريض المفصلي عن أي مريض آخر، وتتم المقاربة بأخذ:

القصة السريرية (المشاهدة)	إجراء الاستجواب	الفحص السريري الدقيق لكافة أجهزة الجسم

أولاً: القصة السريرية والاستجواب:

☒ تتضمن ما يلي:

1. معلومات عامة عن المريض:

1. الاسم.

2. العمر:

- **شاب** يعاني من ألم التهابي الطبيعة في الظهر فيكون التشخيص هو **التهاب فقار مقسط**، أما إذا كان المريض بعمر **70 سنة** ويشكو من نفس العرض سنفكر **بانقراص الفقرات** أو **ديسك** أو **نقائل ورميّة** (خباثات).
- إصابة قلبية لدى **فتاة شابة** ⟵ نفكر بالذئبة الحمامية، أما إصابة قلبية لدى **عجوز** لا نفكر بالذئبة الحمامية.

3. الجنس:

- لأن التشخيص التفريقي الأولي لدى مريض لديه **قلاع فموي ناكس متكرر مزمن** يختلف ما بين الذكور والإناث.

4. السكن.

5. الوزن.

2. الشكوى الرئيسية الحالية:

☒ هي المفتاح الأساسي للتشخيص، وتعني العرض الذي دفع المريض لمراجعة الطبيب مثل ألم في الركبة.

3. القصة المرضية الحالية:

☒ تسلسل ظهور وتطور الأعراض التي يعاني منها المريض مع الزمن، حيث إن معرفة موعد بدء المرض بدقة مهم جداً في التشخيص.

4. حالة المريض الاجتماعية والنفسية.

5. التعرضات المهنية:

- ☒ حدوث ظاهرة رينو عند الأشخاص الذين يعملون في الكومبريسا (آلة لحفر الطريق).
- ☒ كل الآلات المحدثة للاهتزازات يمكن أن تؤدي لظاهرة رينو.

6. السوابق المرضية الشخصية:

- ☒ التهاب الكبد الفيروسي، التهاب البلعوم بالعقديات، الحصبة الألمانية[2]، الزحار[3]، السيلان البني، التدرن، آفات الأمعاء الالتهابية، الصداف.

7. العلاجات السابقة:

- ☒ ويجب الاستفسار عن:
  - ✖ مدى الالتزام بها.
  - ✖ الإيقاف وسببه أهل المريض؟ وهل لأنه لم يستفيد منه أم لأنه عانى من آثار جانبية؟
  - ✖ إضافةً إلى نقل الدم والعمل الجراحي.
- ☒ وتتضمن أيضاً:

1. السوابق العلاجية:

- فعملية نقل الدم قد تكون سبباً في نقل بعض الأمراض كالتهاب الكبد B أو C أو الإيدز.

2. السوابق الدوائيّة:

- **مريضة 65 سنة** تعاني من اضطراب نظم قلبي، تم وصف **دواء بروكائين أميد** لها، عادت بعد شهرين من تناوله تشكو آلاماً وتورّمات في المفاصل، حساسية للضوء، ولوحظ من خلال الفحص السريري وجود التهاب التامور، طفح جلدي أحمر.
  - هذه الأعراض والعلامات تشير لـ **الذئبة الحمامية الدوائية الناتجة عن البروكائين أميد**.
- مريض يأخذ مدرّ بولي، جاء في الليل يشكو من التهاب وتورّم في مفصل إبهام القدم.
  - المدرّ البولي حرّض ارتفاع مفرط لحمض البول فتراكم في المفصل وتظاهر **بالنقرس**.

8. العادات:

- ☒ التدخين، الكحولية، تعاطي المخدرات (يمكن أن يترافق تعاطي المخدرات **بالتهاب مفاصل قيحي** في أماكن غير شائعة كالمفصل القصي الترقي أو المفصل العجزي الحرقفي).

---

[2] الحصبة هي عدوى فيروسية تتسبب في طفح جلدي وردي اللون على الوجه والجذع.

[3] الزحار هو التهاب في الأمعاء يؤدي على إسهال دموي شديد مع حمى وآلام بطن.

9. القصة العائلية:

☒ ونسأل عن الأمراض المفصليّة التي قد يكون لها **سبب وراثي**، مثل:

✘ التهاب المفاصل الرثياني، النقرس، الفصال العظمي، اعتلال المفاصل الفقارية، الذئبة الحماميّة[4]، آفات الأمعاء الالتهابية، حمى البحر الأبيض المتوسط[5]

من المهم في القصة السريرية أن نركّز على:

العمر والجنس والسوابق العلاجيّة والسوابق الدوائية، وذلك لاختلاف التشخيص التفريقي لنفس العرض بسبب هذه العوامل.

ثانياً: استعراض باقي الأجهزة:

☜ لا يقتصر الفحص على مكان شكوى المريض فقط، وإنما يجب استعراض كامل الأجهزة، ويتضمن ذلك:

☞ الرأس والعنق، الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز العضلي الهيكلي، الجهاز البولي التناسلي والجلد.

ملاحظة

- **الإصابات المفصلية** مهما بلغت شدتها قد تقود إلى العجز ولكنها **غير مهددة** للحياة.
- أما **الإصابات الجهازية** المصاحبة لها، كإصابة الأعضاء النبيلة (الكلية والجملة العصبية المركزية والقلب)، فهي التي **تهدد** الحياة، لذلك أمام الشكاية المفصلية يجب علينا التفكير بوجود مرض مناعي ذاتي أو مرض جهازي (روماتيزمي)، ويجب استجواب كافة الأجهزة وبالتفصيل.

مقاربة المريض المفصلي

Approach To The Patient With Rheumatic Disease

تحديد نمط البدء والعوامل المحرضة	⟷	تحديد الأعراض المفصلية والبنى المصابة

أولاً: نمط البدء:

1. البدء الحاد:

✓ أسبابه: آفة خمجية (قيحي)، آفة وعائية (رضي)، نقرسي أو بسبب الحمى الرثوية، يكون الألم خلال ساعات أو أقل من يومين، مثال: شخص نام سليماً وعندما استيقظ وجد ركبته متورّمة.

✓ مثال آخر: ألم في الكتف من البارحة التهاب >> وتر ويكون تدبيره إسعافي.

[4] سنذكر ما سبق من الأمراض في نهاية هذه المحاضرة في الصفحة 27.

[5] نستطيع تشخيصها من القصة العائلية حيث تأتي على شكل نوبات، فأحياناً تحدث مرتين في الأسبوع وأحياناً كل شهرين وفي بعض الأحيان تحدث مرة في العام على شكل ألم بطني وترفّع حروري وآلام في المفاصل تستمر ليومين أو أكثر ثم تنتهي.

2. البدء التدريجي:

✓ يكون خلال أيام أو أشهر أو سنوات (قصة الألم مزمنة)، ويسوء مع التقدم بالعمر، مثال: الفصال العظمي.

3. البدء العفوي:

✓ لا يوجد سبب واضح للإصابة المفصلية.

4. البدء المحرض:

✓ ناتج عن العوامل المحرضة.

ثانياً: العوامل المحرضة[6]:

الرض	بعض الأدوية كالهيدرالازين، البروكائين أميد، أو المدرات	مرض آخر، مثل: آفات الأمعاء الالتهابية، الصداف، السيلان، الإسهالات

ثالثاً: تحديد الأعراض المفصلية(سنفصل بها لاحقاً)

الألم المفصلي وله نوعان ألم ميكانيكي وألم التهابي	تحدد الحركة ودرجة الإعاقة الوظيفية
التورم المفصليّ والضعف العضلي	التظاهرات خارج المفصلية
اليبوسة المفصلية الصباحية	التوعك والوهن والتعب Fatigue, weakness and malaise

رابعاً: تحديد البنى المصابة:

ضمن الجوف الفصلي[7]	حول الجوف المفصلي	خارج المفصل[8]
وتتضمن إصابة البنى الموجودة ضمن جوف المفصل: العظام، الغضاريف، **الغشاء الزليلي**، أو تراكم السوائل ضمن الجوف المفصلي	كإصابة مكان ارتكاز أوتار العضلات أو الأجربة أو **المحفظة المفصلية**	وتكون الإصابة خارج حدود الجوف المفصلي

[6] العوامل المحرضة للألم المفصلي: قد لا تكون موجودة ولكن يجب السؤال عنها واستجوابها.

[7] ضمن الجوف المفصلي: يكون الألم مبهماً لا يحدَّد بدقة أما إذا استطاع المريض تحديد منطقة الألم بدقة فهذا يعني أن الألم حول الجوف المفصلي (ارتكاز وتر أو ارتكاز عضلة).

[8] الألم خارج المفصل: مثلاً إذا كان لديه ألم شديد في كامل الكتف وبعد فحص الكتف تبين أنه سليم ولم يجد الطبيب أي ضرر بالمفصل فهذا يعني أن الألم قادم من خارج المفصل أي من أعضاء أخرى.. مثلاً التهاب المرارة يُحدث ألم رجيع يعود للكتف.

التعب لا يعني دوماً وجود آفة جهازية، إذ يسبب كلّ من فقر الدم والتهاب الكبد التعب للجسم ولكن عندما تترافق الأعراض الجهازية مع التعب فهذا يؤكد وجود مرض جهازي.

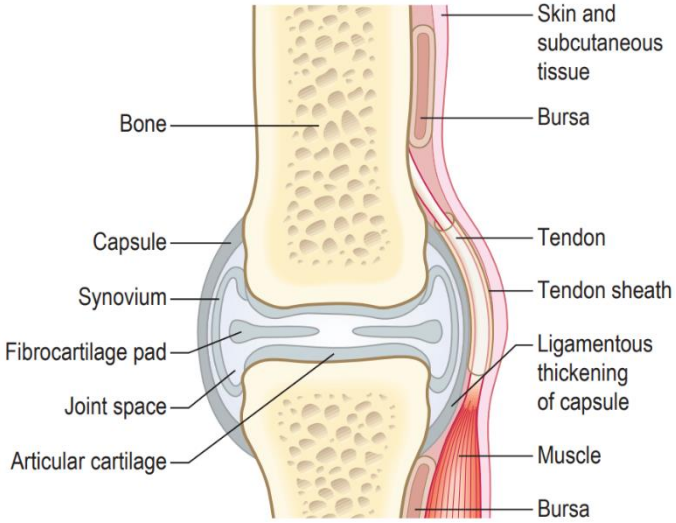
أعراض الأمراض الرثوية The Rheumatological Symptoms

- يأتي المريض المفصلي إلى العيادة الرثوية شاكياً من أعراض معينة تجاه إصابة ما، وتختلف هذه الأعراض باختلاف البُنى المُصابة فقد تكون شاملةً للجوف المفصلي (ألم شامل للمفصل) أو خارج التجويف المفصلي (ألم مُتمركز في موقع الإصابة)، لذلك من المفيد تذكر البُنى المفصلية لفهم آلية تحديد البُنى المُصابة بدقة (مثلاً عند التهاب النسيج الخلوي الموجود في جوار المفصل يجعل تحديد موقع الإصابة صعباً).
- تدرس الأمراض الرثوية المفاصل الزليلية واسعة الحركة ولا علاقة لها بالمفاصل الثابتة (كدروز الجمجمة) ولذلك سنتذكر معاً مكونات المفصل الزليلي:

الغضروف المفصلي Articular cartilage	المحفظة المفصلية Articular capsule	الغشاء الزليلي Synovial membrane
• يغطي السطوح العظمية.	• تحيط بالمفصل وترتكز على العظم.	• يُبطن المحفظة المفصلية مشكلاً التجويف المفصلي، كما يُفرز السائل الزليلي Synovial fluid المزلّق للسطوح المفصلية.

- ويحيط بالمفصل بُنى مجاورة تشمل مرتكزات لأوتار العضلات والأربطة على السطوح العظمية للمفصل.
- تتم حماية وتر العضلة من الاحتكاك مع:
  - العظم والبنى المفصلية، من خلال: الأجربة Bursa.
  - الأنسجة المجاورة، من خلال: غمد الوتر Tendosynovial.

لاحظ الصورة الأتية الّتي توضح مكونات المفصل الزليلي



الأعراض المفصلية Joint Symptoms

1. الألم المفصلي (الميكانيكي والالتهابي):

❖ إنّ الألم هو الدافع الأساسي لمراجعة المرضى للطبيب.

❖ تشكل الشكايات العضلية الهيكلية الألمية حوالي 20% من المراجعات في العيادات المختلفة، لذلك مهما كان اختصاص الطبيب يجب أن يكون لديه فكرة عن الآلام العضلية الهيكلية وكيفية مقاربتها، ليتمكن من إحالتها للأخصائي المعني بالموضوع.

❖ عند مقاربة الألم المفصلي يجب تحديد:

- منشأ ومكان الألم، انتشاراته، مدته، ونمطه (حارق، ممض...) وعلاقته بالجهد.
- الفعاليات الفيزيائية[9] التي تخففه أو تفاقمه.

	الألم الميكانيكي	الألم الالتهابي[10] IMP
تفاقم الألم	ألم النهار غالباً ما يكون ميكانيكياً لأنه يحدث بعد الجهد، ويخف بالراحة	ألم الليل غالباً ما يكون التهابياً لأنه يحدث عفوياً أثناء الراحة ويخف بالحركة (بسبب تحرك العناصر الالتهابية كالبراديكانين والسيتوكينات الالتهابية للتصريف الدوراني)
	لا يوقظ المريض ليلاً	قد يوقظ المريض ليلاً
	لا يترافق مع حرارة	يترافق مع حرارة موضعية
البيوسة الصباحية	يترافق ببيوسة صباحية لعدة دقائق، غالباً لا يترافق بتورم	يترافق ببيوسة صباحية مديدة قد تستمر لأكثر من ساعة، وتترافق مع ألم وتورّم
مثال	نشاهده في التهاب المفاصل الرضي والتهاب المفاصل التنكسي	نشاهده في الروماتيزمات الالتهابية: كالداء الرثياني (التهاب المفاصل الرثياني) والتهاب الفقار المقسط
الدليل	لا يتألم الشخص المتعرض لضربة إذا لمسه أحدهم ولكن بمجرد أن يتحرك أو نضغط على مكان الإصابة سنسبب له الألم	• نتيجةً للارتكاس الخلوي والكيميائي الحاصل بسبب الالتهاب، يتم تحرير البراديكينين والبروستاغلاندين وهي مواد محرّضة على الألم وموسّعة للأوعية الدموية • يؤدي التوسع الوعائي إلى ارتشاح السوائل ضمن أنسجة المفصل الملتهبة مما يسبب الوذمات واحمرار الجلد المحيط، لذلك يترافق الالتهاب مع وذمة واحمرار • يخف الألم الالتهابي بالحركة بسبب زيادة تصريف السّوائل وبالتالي زيادة تصريف العوامل المحرّضة للألم

[9] الفعالية الفيزيائية: هي الوضعية المخففة أو المفاقمة للألم.

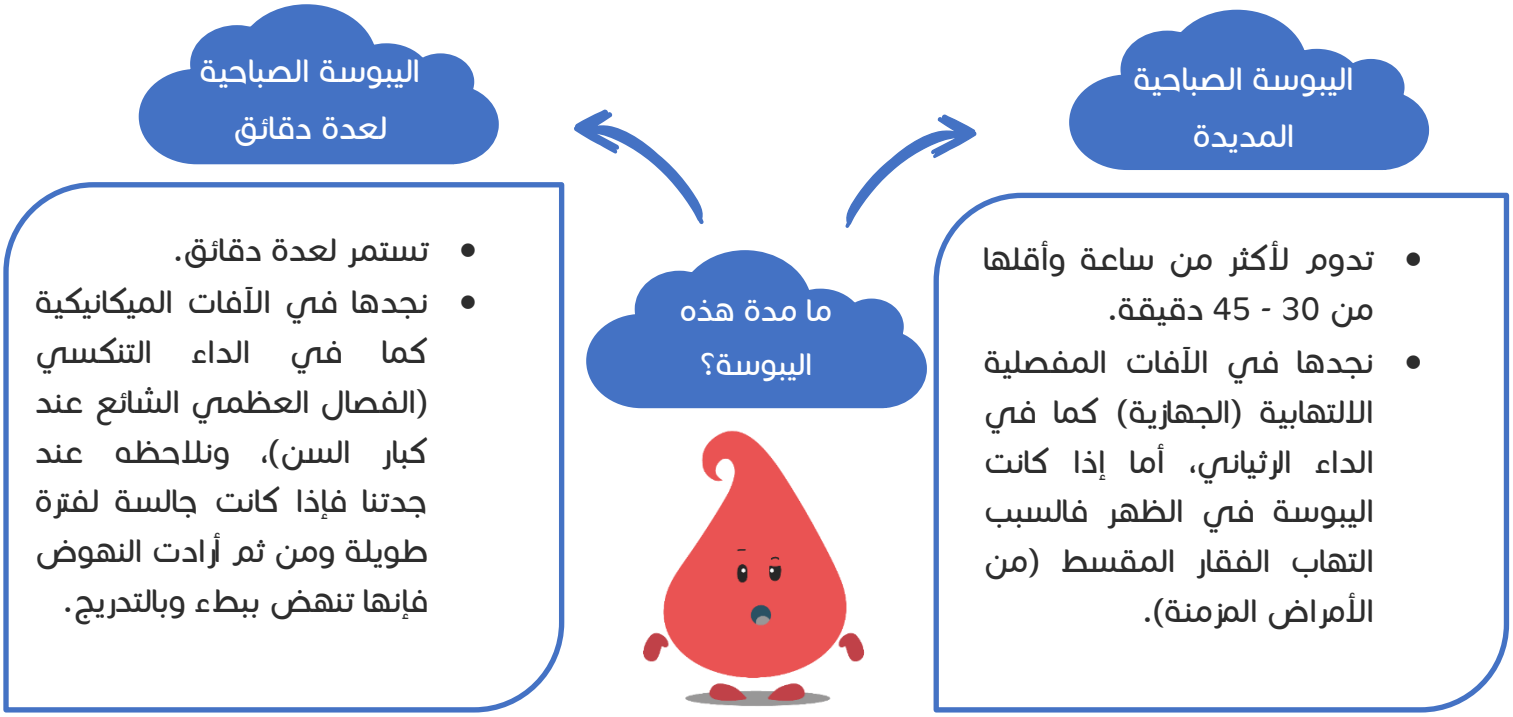
[10] الألم الالتهابي أو ما يسمى الألم الروماتيزمي.

2. التورّم المفصلي Swelling:

❖ يُعتبر أهم علامة في الفحص لأنه يحدد فيما إذا كان لدى المريض ألماً مفصلياً فقط أم أذية التهابية تتجلى بتورم مفصلي.

3. اليبوسة المفصليّة الصباحيّة Stiffness:

❖ عندما يشكو المريض من يبوسة صباحية فالسؤال الأول الذي يجب توجيهه هو: ما هي مدة اليبوسة؟



ملاحظات:

☒ تعد مدة اليبوسة الصباحية مشعراً مهم جداً لـ:

- تحديد شدة المرض في الآفات المفصلية الالتهابية
- تحديد الاستجابة للعلاج
- تحديد العامل المسبب لليبوسة

☒ اليبوسة لعدة دقائق سببها تعب نتيجة جهد مسبق.

☒ أما إذا استمرت لساعات ← يستحيل أن تكون بسبب جهد فهي إما داء رثياني أو التهاب فقار مقسط.

☒ اليبوسة الصباحية يجب أن تكون نصف ساعة على الأقل حتى يكون لها قيمة.

4. تحديد الحركة والإعاقة الوظيفية Impaired function:

❖ من أجل تحديد درجة الإعاقة عند مريض ما، نقوم باستقصاء قدرة المريض على القيام بمهامه وعاداته اليومية كالاستيقاظ، غسل اليدين والوجه، ارتداء الملابس، الذهاب للعمل... الخ.

❖ ومن ثم نحدد درجة الحركة عند المريض:

الدرجة 1	الدرجة 2	الدرجة 3	الدرجة 4
قدرة وظيفية طبيعية	قدرة طبيعية على القيام بالفعاليات رغم وجود انزعاج أو تحدد بالحركة في مفصل أو أكثر	يستطيع المريض أن يقوم **ببعض** مهماته العادية والشخصية	عجز تام أو شبه تام والمريض بحاجة لكرسي متحرك أو ملازمة السرير

5. التظاهرات خارج المفصلية Constitutional symptoms:

- يمكن للتظاهرات خارج المفصلية أن تشمل أعراضاً عامة (بنيوية) ومنها: الحمى، نقص الوزن، نقص الشهية، الشحوب، الوهن والتعب.
- هذه الأعراض غالباً ما تظهر عند وجود حدثية جهازية حادة.
- تتضمن التظاهرات خارج المفصلية العديد من الأعراض نذكر منها[11]:

القرحات الفموية (القلاع الفموي)	ظاهرة رينو	احمرار العينين (التهاب القزحية أو الملتحمة)	جفاف العينين والفم

ملاحظة:

- الحمى ليست عرض حكر على الأمراض الإنتانية، فالخباثات تترافق بالحمى، وكذلك ارتفاع السيتوكينات مثل الانترلوكين-6 يحرض ارتكاس ارتفاع الحرارة.
- الألم المفصلي قد لا يشير إلى أمراض مفصلية فهو عرض لكثير من الأمراض، مثال: مثل مريضة في بيئة ريفية تعمل برعي الأغنام جاءت بشكاية ترفع حروري مع ألم مفصلي في منطقة الوركين والركبتين هنا نفكر **بالحمى المالطية**.

تحديد نموذج الإصابة المفصلية

يتم تحديد نموذج الإصابة المفصلية بمعرفة:

1. عدد ونوع المفاصل المصابة (محوريّة أم محيطية).
2. الإصابة متناظرة أم غير متناظرة.
3. تحديد إذا كانت حادة أم مزمنة.
4. تحرّي كون المريض تعرّض للمرض أو الألم المفصلي سابقاً.



[11] سيتم شرحها ابتداءً من الصفحة 24.

مثلاً: إذا جاء مريض بشكاية تورم في قاعدة الإبهام مع احمرار وسخونة منذ يومين، هنا يجب أن نسأله إذا كان قد تعرض لذلك سابقاً، إذا كان قد تعرض بالفعل هنا نفكر بأنها هجمة لداء النقرس ويكون العلاج بـ الكولشيسين، والمسكنات لا تفيد بهذه الحالة.

5. تحديد فترات التحسن أو الاشتداد (أي هل الإصابة متزايدة، أم تأتيه هجمة التهاب مفاصل ثم يتحسن وبعد بضعة أشهر تأتيه هجمة أخرى).
6. تحديد إذا كانت مخربة أم مشوهة.

7. عدد المفاصل المصابة:

التهاب وحيد المفصل monoartthritis	التهاب قليل المفاصل oligoarthitis	التهاب عديد المفاصل Polyathitis
يصيب مفصل واحد	يصيب عدة مفاصل من 2 - 5	يصيب أكثر من 5 مفاصل
رضي، نقرسي، قيحي، تدرن	التهاب الفقار المقسط ومتلازمة رايتر (التهاب المفاصل الارتكاسي للإنتانات المعوية والبولية)	الداء الرثياني، الصداف[12]، الذئبة الحمامية الجهازية

التهاب المفصل القيحي (انتاني)

- **هو التهاب وحيد المفصل** ويكون تدبيره إسعافي خلال 48 ساعة وإلا سيتشوه المفصل، (أخطره القيح الجرثومي).
- **أعراضه:** يأتي مريض شاب بشكاية تورم ركبة مع سخونة واحمرار وحالة عامة سيئة.

هُنا نقوم فوراً ببزل السائل ثم نقوم بفحص الجراثيم فيه لنعطيه بعدها الصادات الحيوية المناسبة **بالوريد** لمدة أسبوعين ثم نحوله للصادات الحيوية الفموية بعد أن قمنا **بسحب السائل كلياً**.

لا نستطيع أن ننتظر نتيجة الزرع الجرثومي في هذه الحالة لأنها تحتاج ليومين و**الحالة إسعافية**، لذلك نقوم بإجراء تحاليل أخرى مثل **تعداد الكريات البيضاء**، ونعطيه صادات حيوية مخبّرية (هذه الصادات تعطى للجراثيم الشائعة)، بانتظار نتيجة الزرع الجرثومي وإعطاء الصاد الحيوي المناسب.

[12] مرض الصداف الجلدي يصيب المفاصل، مورثاته جلدية ومفصلية، وهو شائع على السطوح الباسطة.

2. نوع المفاصل المصابة:

1. **المفاصل الكبيرة الحاملة لثقل الجسم**: تُصاب في الداء التنكسي البدئي والتهابات المفاصل سلبية المصل.
2. **المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين**: تُصاب في الداء الرثياني، الصداف، الداء التنكسي[13]، الذئبة الحمامية.
3. **المفاصل المحورية**: تُصاب في متلازمة رايتر والتهاب الفقار المقسط، مثل: حزام الكتف والفقرات والوركيين والمفصلين العجزيين الحرقفيين.
4. **المفاصل المحيطية**: مثل المرفق، المعصم، الرسغ، المفاصل السنعية السلامية والسلامية-السلامية، الركبة، الكاحل وباقي مفاصل الجسم.

3. تناظر الإصابة:

داء رايتر	الداء الرثياني
يكون الالتهاب المفصلي قليل المفاصل غير متناظر	يكون الالتهاب المفصلي عديد المفاصل متناظر

4. تحديد نوع الإصابة حادة أم مزمنة:

- **تحديد فترات التحسن أو الاشتداد:**
  - أي هل الإصابة متزايدة، أم تأتيه هجمة التهاب مفاصل ثم يتحسن وبعد بضعة أشهر تأتيه هجمة أخرى.
- **تحديد إذا كانت مخربة أم مشوهة.**

التشخيص السريري للأمراض المفصليّة[14]

من خلال عدد المفاصل والتناظر والالتهاب المفصلي نستطيع تشخيص الحالة سريرياً.

✓ **مريض لديه التهاب ركبة أو ورك وحيد، ظهر منذ يومين (حاد):**

- أول ما نفكر به هو التهاب المفصل القيحي (الإنتان)[15] وخصوصاً إذا كان هناك حرارة عامة، ومن ثم نحدد السبب (رضّي أم نقرسي).

[13] الداء التنكسي البدئي هو الالتهاب المفصلي التنكسي نفسه ولكن يبدأ بعد ال 40 سنة حيث يحدث التهاب عقد في اليدين تسمى (عقد هيبردن) ومن ثم تنتقل للركب ولباقي مفاصل الجسم.

[14] في جميع حالات مرضى الرثوية نستخدم "غالباً" للدالة على توقع تشخيص المرض لأنه لا يمكن الجزم بشكل أكيد.

[15] الإصابة الإنتانية هي إصابة خمجيّة تتظاهر بوجود قيح.

✓ **مريض ركبته متورمة لمدة 6 - 7 أشهر (مزمن) مع حمى وتعرق ليلي:**

- أول ما يخطر ببالنا هو التدرن.

✓ **مريض يشتكي ألماً جديداً في إصبع قدمه (ألم فجائي منعه من النوم):**

- غالباً نقرس، أما إذا كان ألم إصبعه موجود منذ خمس سنوات (فترة زمنية طويلة) ويتفاوت بين زيادةٍ ونقصان فإنّ إصابته غالباً هي روماتيزم.

✓ **شاب عمره 25 سنة يشكو من حرارة 40 منذ يومين مترافقة بألم وتورم في مفصل الركبة دون تعرضه لرض سابق:**

- بما أن مفصل الركبة وحده مصاب، فنحن أمام التهاب وحيد المفصل (إنتان مفصل الركبة).
- بما أن الشكاية ظهرت منذ يومين فنحن أمام التهاب حاد.
- بما أن المريض لم يتعرض لرض سابق فنستبعد وجود التهاب مفصل رضّي.
- إذاً فالتشخيص الصحيح هو: التهاب وحيد المفصل حاد قيحي.

ملاحظة

- الخمج (الإنتان) هو أهم سبب للالتهاب المفصل الوحيد المزمن أو الحاد.
- بعد الانتهاء من مقاربة المريض وتحديد نموذج الإصابة المفصلية نبدأ بالفحص السريري لاستكمال الكشف عن الأمراض الجهازية والروماتيزمية المصاحبة والبنى المصابة...

الفحص السريري لمريض مفصلي The rheumatological examination

- يتم فحص المريض على سرير الفحص الخاص بعد أن ينزع ملابسه حيث نبدأ بفحص الجهة السليمة دوماً للحصول على فحص سريري دقيق ومتقن.
- نفحص كامل أجهزة الجسم لأن الأمراض المفصلية هي **أمراض جهازية**، كما يجب فحص كافة المفاصل في الجسم.
- يتضمّن الفحص السريري القيام بـ:

1. فحص العلامات الحيوية: النبض، الضغط، الحرارة، الوعي، معدل التنفس (يتم فحصهم في البداية).
2. التظاهرات الجهازية المرافقة (مشاكل صدرية، هضمية، كبد، طحال...).
3. الفحص المفصلي.

عند القيام بالفحص المفصلي يجب الالتزام بالنقاط الآتية:

✓ المقارنة مع الجهة المقابلة، أي إذا قال المريض أن كتفه الأيمن يؤلمه نقوم بفحص الكتفين الأيمن والأيسر بشكل متزامن.

✓ تحديد مكان الإصابة (داخل أم خارج الجوف المفصلي).

الفحص السريري لمريض الروماتيزم

❖ **يشمل:**

- التأمل العام General inspection والتأمل inspection.
- الجس والحركة.
- القياس والذي نستخدمه في بعض الحالات مثلاً:
  - مريض لديه إصابة في الظهر لنرى هل يوجد تحدد لعضلات العمود الفقري أم لا؟

❖ **والهدف** من الخطوات السابقة هو تحديد البنى المصابة:

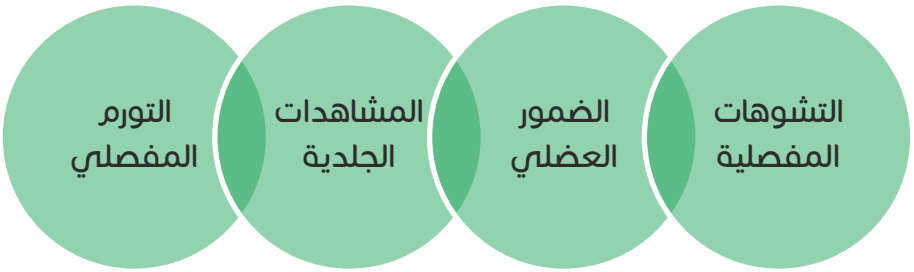
- (الإصابة ضمن الجوف المفصلي، حول الجوف المفصلي، خارج المفصل).

التأمل العام General inspection:

✓ نقوم به منذ اللحظة الأولى لدخول المريض للعيادة، لأنه يعطي فكرة عن درجة **العجز الوظيفي**، من خلال ملاحظة:

- **مشية المريض**: الألم، الصعوبة، الوضعية وحاجة المريض لاستخدام وسائل مساعدة كالعكازة مثلاً، مشية البطة (عوز فيتامين د).
- **هيئة المريض ولون وجهه**.
- **طريقة المريض في نزع ملابسه**[16]: لأن التهابات المفاصل قد تعيق المريض عن القيام بهذه المهمات اليومية.

التأمل inspection:



1. المشاهدات الجلديّة:

- وتشمل الوذمات، الدمامل، النواسير، والخراجات في حال وجودها.
- **التوسّفات**: مثل الصّداف فهو مرض جلدي ومرض مفصلي جهازي.
- **التبارزات والنتوءات**: توجهني للإصابة النقرسيّة، لأن النتوءات تنتج عن وجود ترسبات محيطية.

[16] (يجب أخذ إذن المريض طبعاً).

- **الندبات الجراحية:** تتشكل فوق المفصل بسبب عمليات استئصال غضروف أو الغشاء الزليل في الركبة.
- **احمرار الجلد الساتر للمفصل:** من العلامات الالتهابية الهامّة التي تلاحظ في التهاب المفصل القيحي، الرضي، النقرسي والتهاب المفاصل في الحمى الرثوية لأن الاحمرار دليل التهاب حاد.
- **الضخامة:** التورّم المفصلي[17].
- **الاندفاعات الجلدية:** وهي إما اندفاعات صدافيّة أو اندفاعات فرفريّة.

ملاحظة

- لا يُشاهد الاحمرار في الأمراض المزمنة كالداء الرثياني.
- في التهاب المفصل التنكسي لا يوجد احمرار فقط تضخّم.



النتوءات الناتجة عن الترسبات المحيطية لبلورات حمض البول لمرضى النقرس



الصورة العلوية تمثل اندفاعات فرفرية، لاحظوا أصدقائي الفرق بينها وبين الاندفاعات الصدفية والّذي سنشرح كيف نميزهم في الفقرة القادمة



لاحظوا في الصورة أعلاه الّتي تمثل مِرفق مريض صداف حيث أن:

السهم الأسود: يشير التوسفات الجلدية.

السهم الأبيض: يشير إلى الاندفاعات الصدفية.



أما في الصورة العلوية لاحظ الاحمرار في التهاب المفاصل القيحي



انظر إلى التضخّم لقدم مريض التهاب مفاصل تنكسي (تذكر لا يوجد احمرار)

[17] سنتحدّث عن أسباب التورّم المفصلي فيما بعد.

كيف نميز الاندفاعات الصدافيّة عن الاندفاعات الفرفريّة؟

- **الاندفاع الصّدافي:**

يتميّز بظهور لويحات حمامية متقشرة (توسّفات حمراء) على السطح الباسط للمرفق، كما في التهاب المفاصل الصدفي.

- **الاندفاعات الفرفرية:**

تتميّز بظهور نقط حمراء صغيرة على الجلد، وتُعزى الاندفاعات الفرفريّة لسببين:

1. **تمزّق الشعيرات الدمويّة:** ناتج عن نقص الصفيحات الدموية.
2. **شرى (توسّعات وعائيّة):** ناتجة عن التهاب أوعية بفرط التحسس.

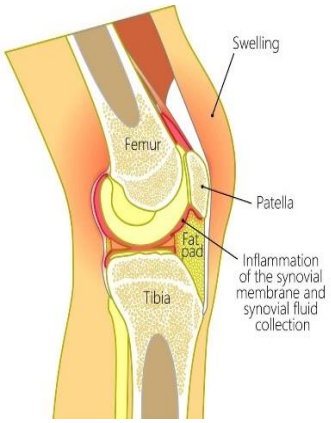
أي عندما نشاهد اندفاعات فرفريّة على الجلد فيجب تحديد سببها لنعرف من ماذا يعاني المريض؟ نقص صفيحات أم التهاب أوعية بفرط تحسس؟

كيف يتم التفريق بين الفرفرية الناتجة عن تمزّق الشعيرات الدموية والفرفرية الناتجة عن الشرى؟

يتم التفريق بطريقتين

- بالضغط على مكان النقط الحمراء فإذا زال الاحمرار فالسبب شرى وإن لم يزول فالسبب تمزّق شعيرات دمويّة
- إذا كانت الفرفريات نافرة فالسبب التهاب أوعية بفرط التحسس (توسع وعائي) وإن لم تكن نافرة (بمستوى سطح الجلد) فهي فرفرية تمزق شعيرات دموية

2. التورّم المفصلي:



✖ إنّ أذيّة أي بنية مفصلية ينتج عنها ضخامة، ومنه فإن **أسباب التورّم المفصلي**[18] هي:

1. التهاب الغشاء الزليلي synovitis[19]:

➢ في **الحالة الطبيعية** يكون الغشاء الزليلي **طبقة واحدة** ولكن عندما يتأذى فإنه يتثخّن إلى (4 – 5 طبقات) مما يعطي المظهر المتضخّم للمفصل وينشأ ما يسمى **بالخمل الزغابي**.

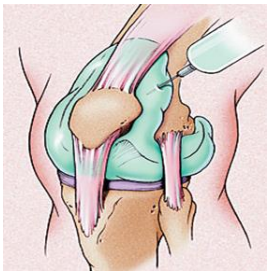
➢ تختلف درجة التهاب الغشاء الزليلي فهي: شديدة في الداء الرثياني. خفيفة إلى معتدلة في الداء التنكسي.

[18] الورم يختلف عن التورّم، فالورم هو شذوذات خلوية من المحتمل أن تكون سرطانيّة أما التورم فهو عبارة عن التضخم.

[19] أكثر ما يُشاهد هذا الالتهاب في الداء الروماتويدي.

2. الانصباب المفصلي Articular Effusion:

➢ وله عدة أسباب منها:

انصباب قيحي: سببه التهاب المفاصل القيحي الذي يؤدي لتجمع القيح داخل المفصل	انصباب دموي: سببه مرض الناعور وحدوث نزوف عفوية تؤدي لانصباب دموي في المفصل	سبب رضّي	

➢ يتميّز الانصباب المفصلي أن حدوثه يؤدي إلى غياب المعالم التضريسية للمفصل، فيبدو بشكل كروي وتغيب التبارزات والنتوءات العظمية الطبيعية وذلك بسبب التضخّم.

3. الضخامة العظمية Bony Swelling:



➢ سببها الأساسي هو **التهاب العظام**.

➢ عندما تتضخم النهايات العظمية يصبح المفصل ذا ملمس قاسٍ وغير متحرك.

➢ كما تدل **الضخامة العظمية** على:

1. وجود مناقير عظمية.
2. تثخّن العظم تحت الغضروف.
3. التهاب المفاصل التنكّسي[20].

➢ تتميّز الضخامة العظمية بأن المفصل يكون بارداً والإصابة مزمنة ولكنها **لا تؤدي لتغيير المعالم التضريسية للمفصل فقط تضخمه**.

الضخامة العظمية ذات السبب الهرموني تشمل كافة المفاصل في الجسم بخلاف الضخامة ذات المنشأ الالتهابي التي تنحصر على المفصل الملتهب.

خُلاصة

○ قمنا بتأمل المريض ومن ضمن المشاهدات الجلدية وجدنا تورّماً مفصلياً (ضخامة) لا نقف عنده بل يجب تحديد سببه عن طريق جس المفصل:

عندما يكون الجس ناعماً وإسفنجياً[21] أو عجينياً وبشكل نعل الفرس، فالسبب: التهاب في المفصل وتكاثر الغشاء الزليلي	إذا لاحظنا عبر الجس وجود كمية من السائل، فالسبب: انصباب مفصلي	عندما نجس كتل غير متحركة وذات ملمس قاسٍ والمفصل بارد، فالسبب: التهاب المفصل التنكسي وضخامة عظمية

[20] يصيب التهاب المفاصل التنكّسي المفاصل التي تتعرض لجهد كبير (رض متكرر على العظم يؤدي لتضخمه) مثل مفاصل اليدين.

[21] الملمس الاسفنجي للمفصل دليل وجود الارتشاح على حساب الأنسجة الرخوة.

3. التشوّهات المفصليّة:

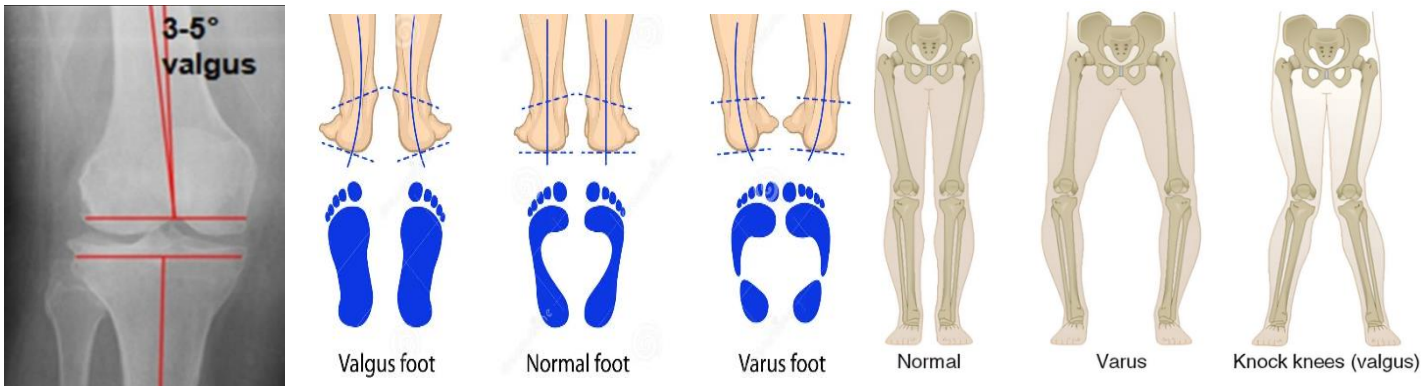
- سببها:
  - إما **انحراف المفصل** عن الخط المتوسط.
  - أو سوء **ترصيف المفصل** (خلع).
- لكشف التشوهات المفصليّة يجب أن يكون الطبيب على دراية سابقة بالشكل السوي للمفصل (التضاريس والوضعية بحالة الراحة والعمل). ويمكن للتشوّه أن يكون انحراف أو تضخم أو خلع بالمفصل[22] .
- مثال عن تشوه المفصل بالانحراف: **التغير الثابت** في مفصل الركبة والذي يسبب الفحَج أو الروَح.

بعض التشوهات الشائعة في الأمراض الرثوية

- **الرَوَح Valgus**: هو انحراف محور المفصل عن الخط المتوسط **نحو الخارج** (الركب متقاربة والساقين متباعدين).
  - هو ناتج عن تنكس في الناحية **الوحشية** للركبة.
- **الفحج Varus**: هو انحراف محور المفصل عن الخط المتوسط **نحو الداخل** (الركب متباعدة والساقين متقاربين).
  - هو ناتج عن تنكس في الناحية **الانسية** للركبة.
- **الخلع وتحت الخلع**: عدم تطابق السطوح المفصلية، أي تفرّق اتصال تام أو جزئي في الجوف المفصلي.
  - **في الخلع**: يخرج الطرفان العظميان من التجويف المفصلي (تفرق اتصال تام).
  - **تحت الخلع**: يخرج جزء من الطرفيين العظميين من التجويف (تفرق اتصال جزئي).
- **تشوه ثابت بالانعطاف**: هو المفصل الذي **لا يمكن بسطه**، إذ تكون حركة البسط فيه محددة.
- **تشوه ثابت بالانبساط**: هو المفصل الذي **لا يمكن عطفه**، إذ تكون حركة العطف فيه محددة.
- **مفصل شاركو Charcot's joint**: شائع عند مرضى السكر، حيث يعاني المرضى من التهاب أعصاب يؤدي إلى غياب الحس في المفصل وبالتالي كل الأذيات (كسور-كدمات...) تؤدي إلى تشوه المفصل دون شعور المريض.
  - **علاجها**: بتثبيت المفصل ومسكنات.



[22] خلع المفصل يسبب تشوهه لأنه يغيّر محوره.



لاحظوا الفرق بين الرَوَح والفحج بالنسبة للركبة والقدم الطبيعية في الصورة اليمنى وزاوية انحراف المفصل في الرَوَح في الصورة اليسرى

4. الضمور العضلي:

➢ أسبابه:

- عدم استعمال المفصل بشكل مزمن، وغالباً يكون خوفاً من الألم أو لوجود عائق آخر.
- التهاب الأنسجة المحيطة بالمفصل.
- الاعتلالات العصبية الانضغاطية (إصابة العصب المعصب للعضلة) كما في **متلازمة نفق الرسغ** حيث ينضغط العصب الناصف فتضمر عضلات الإلية.

➢ ما يهم في الضمور العضلي حجم العضلة والقوة العضلية.

ملاحظة

الضمور العضلي دليل اللإزمان في الحالة المرضية واللاستعمال حيث يكون حجم المفصل طبيعي إلا أن العضلات المحيطة به قد أصابها الضمور لأن عدم حركة المفصل تعني عدم وصول التنبيهات المحرّكة للعضلات المحيطة به.

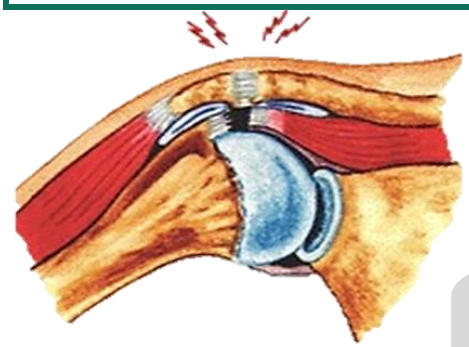
الجس:

✓ نقوم بجس المفصل ونفحص:

- **الحرارة الموضعيّة**: ونجسها في موضعين:
  - **ظهر اليد**: يستخدم لجس الحرارة الموضعيّة **للمفاصل الكبيرة**.
  - **الأصابع**: تستخدم لجس الحرارة الموضعيّة **للمفاصل الصغيرة**.

ملاحظة:

- نجس الحرارة بظهر اليد وليس بباطنها لأن مستقبلات الحرارة بظهر اليد عددها أكبر.
- يجب جس الطرفين للتمييز بين حرارة المفصل المصاب وحرارة المفصل السليم المقابل له.
- كما يجب جس المنطقة حول المفصل، حيث تكون حرارة المفصل بالحالة الطبيعية أقل مما حوله لأنه عظم وليس فيه تروية، فعندما تكون حرارته مساوية لحرارة المحيط هذا يدل على ترفع حروري في المفصل.



الإيلام المفصلي: ونتحراه بطريقتين حسب نوع المفصل:

- بتحريك المفصل إذا كان كبيراً كالكتف.
- بالضغط على المفصل إذا كان صغيراً كالمفاصل بين السلاميات.

تذكرة

- إذا كان الألم المفصلي موّضَعي فالإصابة خارج أو حول الجوف المفصلي.
- إذا كان الألم المفصلي شامل فالإصابة داخل الجوف المفصلي.

التورّم المفصلي: لتحديد طبيعة التورم وسببه.

الفرقعة المفصلية Crepitus:

- صوت يصدر عن المفصل بسبب احتكاك السطوح العظمية، ويدل على **إزمان الآفة**، وهي أذية ناجمة عن ذوبان الغضروف الحامي ونجدها عند مرضى الداء التنكسي.
- تفحص الفرقعة المفصلية بالجس والحركة حيث يتم وضع اليد الجاسة فوق المفصل بينما تقوم اليد الأخرى بتحريك المفصل **بشكل منفعل**.
- طقطقة المفاصل التي يشكو منها المرضى أثناء الحركة غير مهمة سريرياً، أما الفرقعة المسموعة أو المجسوسة أثناء الفحص السريري هي ما يهم الطبيب.
- تُسمع الفرقعة المفصليّة بشكل واضح فقط في الحالات الشديدة، بينما في الحالات الخفيفة لا تُسمع وإنما تُجس.

الحركة Move:

- نقوم بتحريك المفصل الذي يشكو منه المريض **بحركة فاعلة وحركة منفعلة** لنتحرّى ما يلي:
  - مدى الحركة الفاعلة والحركة المنفعلة وتحددها.
  - **بنية المفصل**: وتكون الحركة **المنفعلة** هي الأهم.
  - **وظيفة المفصل**: وتكون الحركة **الفاعلة** هي الأهم.
  - عندما يستطيع المريض القيام **بالحركات المنفعلة** فالجوف المفصلي **سليم**، لكن عندما لا يستطيع القيام **بالحركات الفاعلة** فهو يعاني من مشكلة وترية-عصبية (أي بالعضلات حول المفصل المطلوب فحصه).

ثبات المفصل: لتحرّي ذلك نحرّك المفصل **بوضعيات شاذة** فإذا تحرك فهو غير ثابت بسبب أذية الأربطة.

فكرة

فحص ثبات مفصل الركبة:
في الحالة الطبيعية تتحرك الركبة بالعطف والبسط فقط، لكن عند وجود أذية رباطيّة يمكن أن تتحرك باتجاه اليمين واليسار.

ما الفرق بين الحركة الفاعلة والحركة المنفعلة؟

الحركة المنفعلة: هي الحركة التي يؤديها الطبيب على المريض

الحركة الفاعلة: هي الحركة التي نطلب من المريض أن يقوم بها

كيفية فحص حركة المفاصل

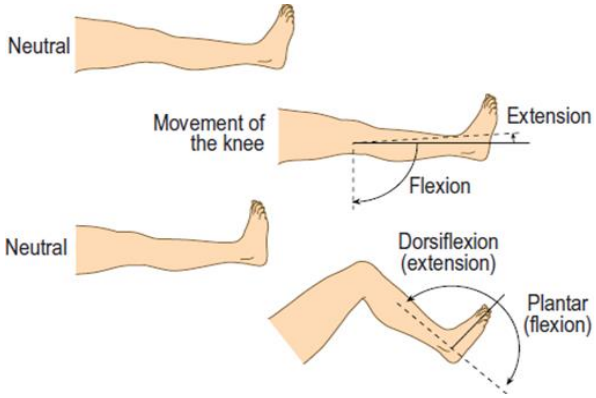
- **نقوم بفحص الحركة الفاعلة والمنفعلة** بدءاً من الوضعية صفر (الوضعية التشريحية) للجسم وينطبق ذلك على كل مفاصل الجسم **عدا** مفصل الكتف فتكون وضعية فحصه بحيث نضع العضد بجانب الجسم والذراع معطوف عليه بشكل دائم.
- تستخدم الحركة الفاعلة للكشف عن وجود معيقات الحركة: ألم، تيبّس، تشوّه، فرقعة عظميّة.
- تفحص الحركة المُنفعلة بلطف، فقد تكون محددة بسبب:
  - ✓ تكلّس المفصل.
  - ✓ الألم الناتج عن التشنج العضلي.
  - ✓ الانصباب أو التهاب الغشاء الزليل.
  - ✓ وجود تشوّه ثابت في المفصل.

فتحريك المفصل بشكل **عنيف** سيسبب الرض للمفصل

- مسح الجهاز الحركي **GALS** يدل على:
  - ✓ GAIT: فحص مشية المريض.
  - ✓ ARMS: فحص الذراعين.
  - ✓ LEGS: فحص الساقين.
  - ✓ SPINE: فحص العمود الفقري.
- تفحص حركة المفاصل لتحديد درجة تحدد الحركة أو على العكس لتحديد فرط الرخاوة.

فيديو من Macleod يوضح كيفية إجراء فحص GALS

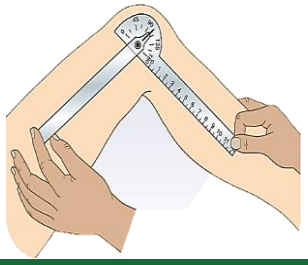
فرط رخاوة حركة المفصل:



- **فرط رخاوة طبيعي:**
  - كما في العرق الصيني الذي يتمتع برخاوة أكثر من باقي الأعراق.
- **فرط رخاوة مرضي:**
  - يُشاهد في أمراض النسيج الضام الرثوية، ويدل عليه قدرة المريض على بسط الركبة أو المرفق أكثر من 5 درجات، أو جعل الإبهام موازياً للساعد.

القياس Measure:

- في النهاية نقوم بقياس مجال حركة المفصل باستخدام المقياس الزاوي goniometer.



ألم الظهر Back Pain

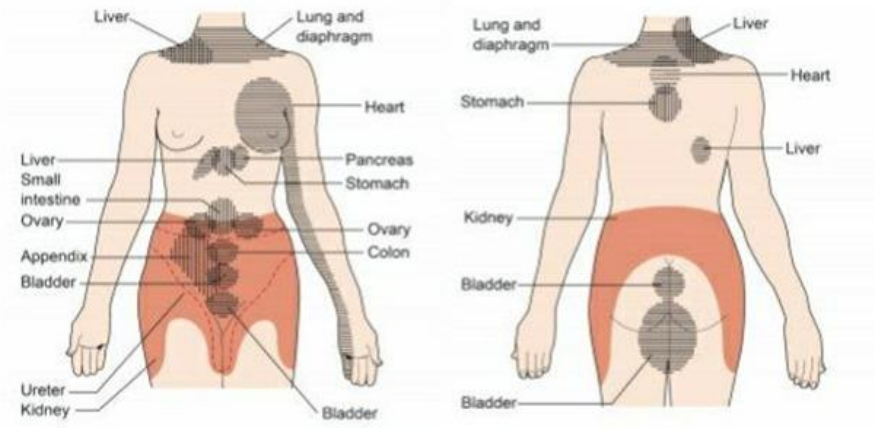
- وله عدة أسباب:
  - تشنّجي: برد أو حركة عضليّة خاطئة.
  - انقراص بالفقرات يسبب ضغط على الأعصاب فيتولد الشعور بالألم (ديسك).
  - إصابات شوكية نتيجة حادث أو رض أو طلق ناري.
- ويمكن أن نصنف بقية الأسباب إلى: داخلية المنشأ وخارجية المنشأ:

الأسباب	داخلية المنشأ: تتعلق بالعمود الفقري بحدّ ذاته	خارجية المنشأ: أذيات متوضّعة خارج العمود الفقري
أسباب ميكانيكية	آفات الحبل الشوكي	أم الدم الأبهرية
أسباب التهابية	مثل اعتلال مفاصل الفقار (التهاب الفقار المقسط)	التهاب البنكرياس، الغدة الدرقية
أسباب إنتانية	الحمى المالطية	التهاب الحويضة والكلية
أسباب ورمية	خباثات بدئية أو انتقالية	آفات موضعية في العضلات الهيكلية

الأسباب	داخلية المنشأ: تتعلق بالعمود الفقري بحدّ ذاته	خارجية المنشأ: أذيات متوضّعة خارج العمود الفقري
أسباب استقلابية	مثل أمراض العظام الاستقلابية وهي: هشاشة العظام وتليّن العظام (عندما تتسبب بانهدام فقري)، داء باجيت العظمي (عندما يضغط على البنى المجاورة)	الألم الرجيع بسبب الآفات البطنية والصدرية

يجب ألاّ ننسى الألم الرجيع وخصوصاً في حالات الإسعاف، أمثلة:

- الألم الزنّاري الذي يمتد إلى الظهر يشير إلى التهاب بنكرياس حاد.
- الألم بين الكتفين يشير إلى تسلّخ الأبهر.
- الألم الشرسوفي يشير إلى احتشاء عضلة قلبية سفلي أو قرحات.
- ألم الكتف الأيمن يشير إلى مشكلة في المرارة أو الرئة.



نماذج الألم الرجيع

ألم الطرف Limb Pain

❖ **أول ما يجب التحرّي عنه في آلام الطرف هو الإصابات الوعائية. ومن أسبابه:**

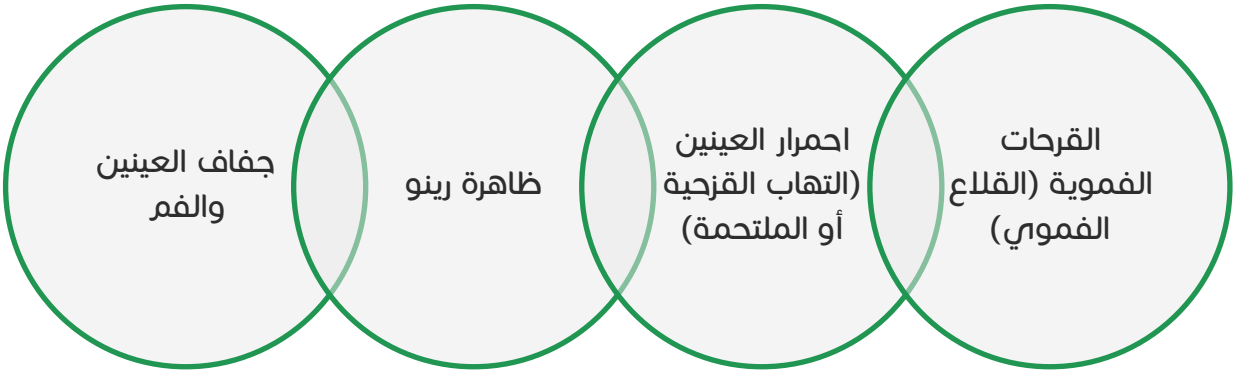
- **الرضوض**
- **إصابة العضلات:**
  - **التهاب المفاصل الرثياني** Rheumatoid arthritis.
  - **ألم العضلات الرثوي** Polymyalgia rheumatica:
    - **وهي نوع من أنواع الروماتيزم الالتهابي، يصيب المسنين ويتميز بألم عضلي في الكتفين والحوض.**

- التهاب غمد الوتر Tenosynovitis.
- إصابة العظام: مثل: تلك المتعلقة بالعظم والنقي Osteomyelitic، الأورام.
- إصابة المفاصل: تسبب العرج أو ضعف الفعالية الوظيفية للطرف.
  - مثل: التهاب وحيد المفصل، التهاب عديد المفصل.
- الاعتلالات العصبية Neuropathy.
- انضغاط الأعصاب: ويتظاهر بألم حارق.
- بتر الطرف: ويخلّف أحياناً ألماً مزمناً يدعى ألم الطرف الشبح (Phantom limb pain).
- التهاب الأوعية Vasculitis (الشريانية والوريدية):
  - صمّة شريانية أو التهاب وريد خثاري:
    - ✖ وقد تكون مهددة للحياة، لأن نقص التروية يعطي مظهر الزّرقة والبرودة في الطرف كما يولّد الشعور بالألم.
    - ✖ في هذه الحالة يجب التدخل الإسعافي السريع فخلال ساعات يجب فتح الشريان لإعادة التروية، لأن نقص التروية المديد يسبب تموّت أنسجة الطرف مما يستدعي البتر.

ملاحظات

- ارتفاع التوتر الشرياني، السكري، ارتفاع الكولسترول، التدخين: جميعها عوامل مؤهبة لمشكلة عصيدية أو خثرة يمكنا أن تسبب نقص التروية.
- يجب التأكد من حالة نقص التروية وربطها بالمرض العصيدي.
- نقص التروية القلبية تشير إلى احتمال حدوث نقص تروية بالأطراف.

التظاهرات خارج المفصلية للمرضى الرثويين



القرحات الفموية (القلاع الفموي) Oral Ulcers:



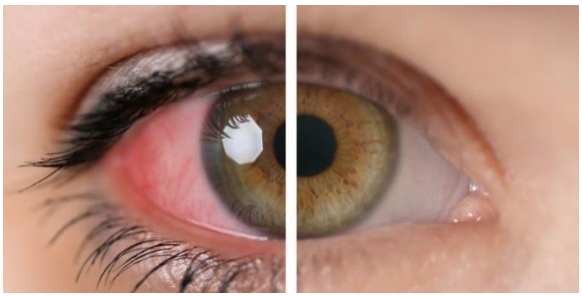
التقرحات الفموية لمريض داء بهجت

- لا نقصد القلاع الفموي الشائع المعزول الذي يأتي بعد الدورة الطمثية أو بعد أكل المكدوس أو الباذنجان، إنما نقصد القلاع الفموي الذي هو آفة تقرحيّة محاطة بهالة حمراء تترافق مع بعض الأمراض الرثوية، مثل:
  - الذأب الحمامي الجهازي تكون فيها القرحات الفموية غير مؤلمة (شائع بين الإناث في سن النشاط التناسلي).
  - داء بهجت يكون فيه القرحات الفموية مؤلمة (شائع بين الذكور في منطقة البحر الأبيض المتوسط).
- يمكن أن يظهر القلاع في المناطق التناسلية على كيس الصفن مثلاً ويسمى القلاع التناسلي.

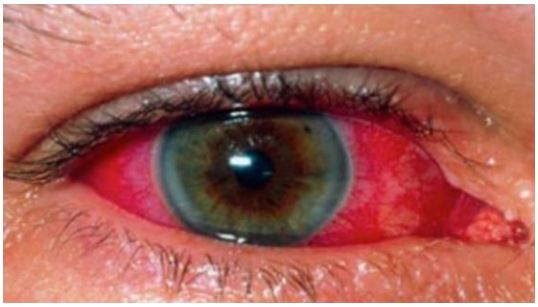
التهاب القزحية (احمرار العينين) Redness eyea:

- ويترافق مع الكثير من الأمراض الرثوية.
- إذا كان الالتهاب مقتصراً على القزحية ويتظاهر باحمرار العين وألم ودماع (كثرة إفراز الدمع) وخوف من الضياء فنحن أمام التهاب قزحية[23].
- أما إذا كان الالتهاب شاملاً لكامل القميص العضلي الوعائي فنحن أمام التهاب عنبيّة شامل.
- كل مريض التهاب عنبة يحول إلى أمراض المفاصل والمناعة لنفي الأمراض المناعية المرافقة، حيث أن التهاب باطن العين مثلاً نلاحظه في **داء بهجت** والتهاب الصلبة في **الداء الرثياني**.

يتألف القميص العضلي الوعائي (عنبية العين Uvea) من: القزحية، المشيمية، الجسم الهدبي.



التهاب قزحية



التهاب عنبية شامل

ظاهرة رينو Raynaud's Phenomenon:

- وهي رد فعل شاذ للأوعية الدموية تجاه البرد أو الشدة[24] (فرط استجابة وتقبّض وعائي شديد).
- ودائماً تكون التهاب قليل المفاصل.

[23] يدعى التهاب القزحية في المراجع بالتهاب عنبية أمامي.

[24] الشدة: هي التوتر، القلق، الخوف.

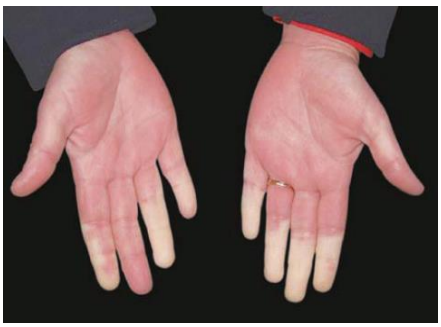
لظاهرة رينو نوعان:

1. **بدئية**: وتدعى **داء رينو**، تتحرض بثلاث عوامل: البرد، الشدة النفسية والتدخين، تتركز الإصابة باليدين والقدمين ولا تترافق مع نخر أو تموّت. ليست خطيرة ونجدها **عند الاناث والذكور مع رجحان أكبر للاناث**. علاجه بتجنب العوامل المؤذية.
2. **ثانوية**: وتدعى **ظاهرة رينو**، تكون الإصابة مرافقة لأمراض جهازية أخرى وتشمل إصابة الأصابع بالتقرحات والتنخّر وصلابة الجلد (كما في الداء الرثياني والذئبة الحمامية)، وهي خطيرة لأن التقبض الوعائي يكون شديداً، تصيب كل الفئات العمرية والجنسين **بشكل متساوي**.

الآلية الرئيسية

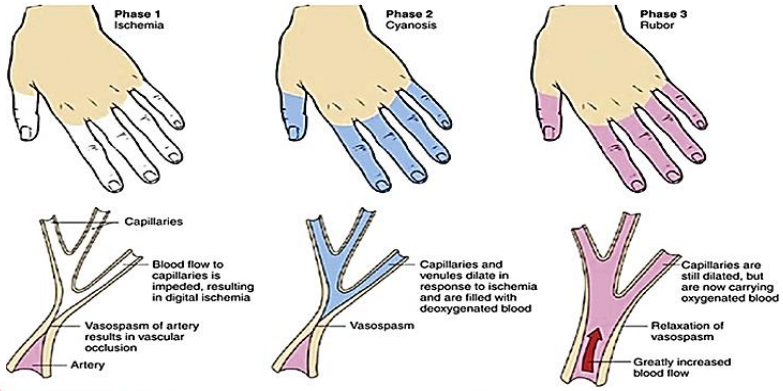
- في حالة البرد أو الشدّة تتقبض الأوعية الدموية في الجلد للمحافظة على الحرارة داخل الجسم (في حالة البرد) وللحفاظ على تروية الأعضاء النبيلة (في حالة الشدة).
- لكن في ظاهرة رينو **تتقبض الأوعية** السابقة استجابةً للبرد أو الشدة **بشكلٍ شاذ وشديد** (فرط استجابة)، إلى درجة تسبب نقص تروية أطراف الأصابع، وبالتالي شحوب الأصابع.
- تتعاقب دورة رينو ابتداءً بالشحوب ثم الازرقاق ثم الاحمرار (التبيّغ) ثم تعود للونها الطبيعي، كما يلي:

بدايةً تتلون الأصابع باللون الأصفر (شحوب) نتيجة انخفاض كمية الدم الوارد إليها بسبب التقبض الوعائي (شلل جزئي للألياف العضلية بالأوعية الدموية)	ومع مرور الوقت ونتيجةً لاستمرار التقبض ونقص التروية (نقص الاكسجة) تتلون بالأزرق بسبب تراكم ثنائي أكسيد الكربون في الأنسجة الدم	ثم تتلون بالأحمر نتيجة معاودة التوسع الوعائي بعد الازرقاق فتعود التروية الدموية









ملاحظة

داء رينو: ينتشر في اليدين الاثنتين وفي كل أصابع اليد الواحدة.
ظاهرة رينو: عادة غير متناظرة بين الأصابع.

أسباب ظاهرة رينو

- **طبيعية غير مترافقة مع حالات مرضية:**
  - تحدث عند الإناث ذوات الأعمار الصغيرة، نتيجة التعرض للبرد، تعود لوضعها الطبيعي بالدفء.
- **أسباب ارتكاسية:**
  - استخدام آلات المحدثة للاهتزازات.
- **آفات النسيج الضام:**
  - صلابة الجلد، متلازمة كريست CREST Syndrome.
  - التهاب المفاصل الرثياني Rheumatoid Arthritis
  - الذأب الحمامي الجهازي Systemic Lupus Erythematosus.
  - داء النسيج الضام المختلط Mixed Connective Tissue Disease.
  - التهاب العضلات Polymyositis.
  - التهاب الشرايين العقدي Polyarteritis Nodosa.
- **أمراض الشرايين:**
  - الصمّات والخثارات، داء برجر (التهاب الأوعية الخثري الساد)، الرضوض.
- **الأمراض الدموية:**
  - احمرار الدم، الابيضاض، اضطراب بروتينات الدم، داء الراصات الباردة.
- **الأدوية:**
- حاصرات بيتا (مقبضات وعائية)، مركبات الأرغوتامين أو الفينيل كلورايد.

جفاف العينين والفم:

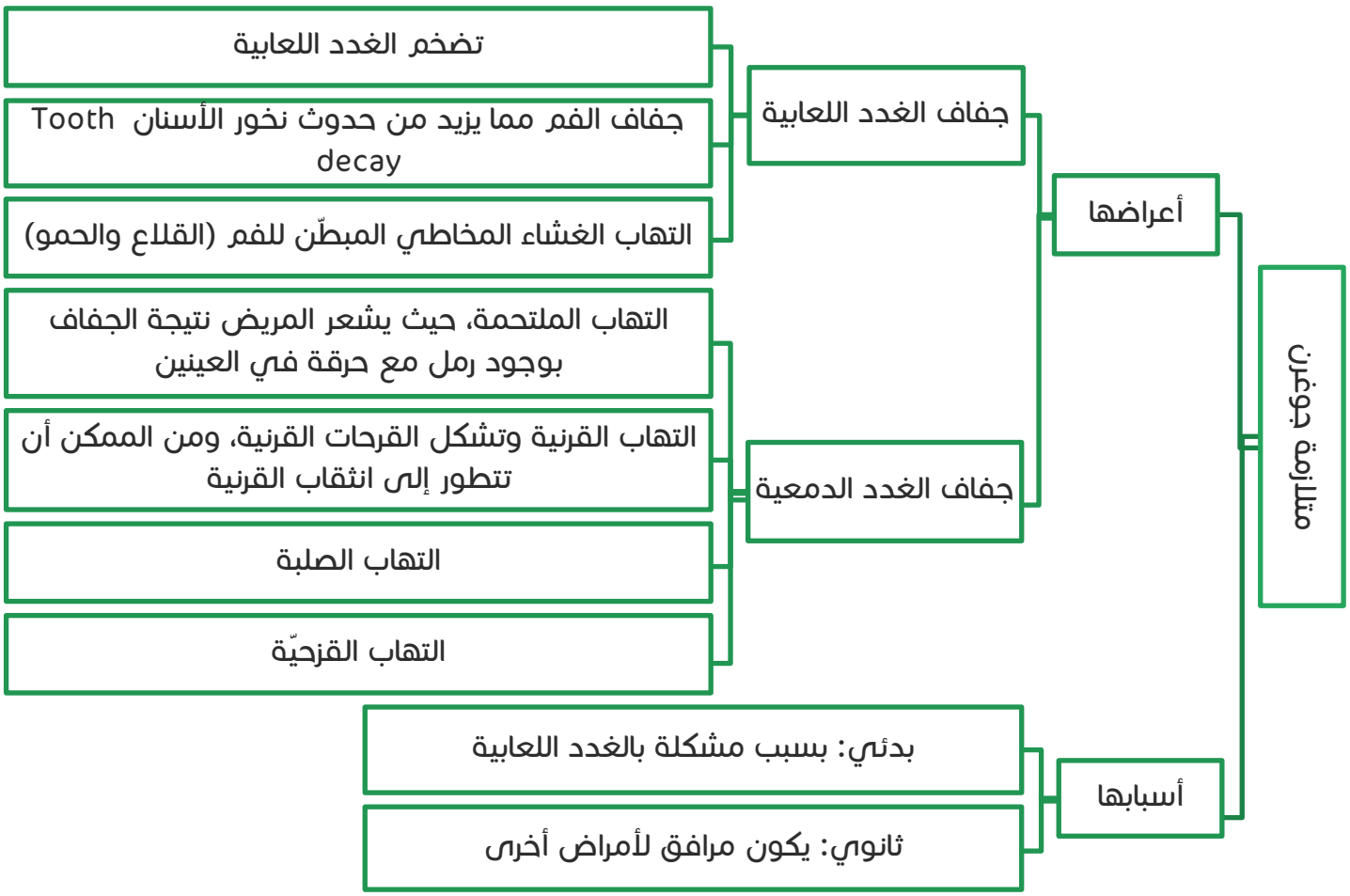
- وهي ظاهرة خارج مفصلية تترافق مع مرض روماتيزمي يدعى متلازمة جوغرن.

متلازمة جوغرن Sjogren's Syndrome:

هي اضطراب في الجهاز المناعي يحدده أكثر أعراضه شيوعاً جفاف العين وجفاف الفم. ترافق هذه الحالة في كثير من الأحيان اضطرابات أخرى في الجهاز المناعي، مثل التهاب المفاصل الروماتيدي، وهي مرض مناعي ذاتي.

Extra

المصاب بمتلازمة جوغرن لا تدمع عيناه عند تقشير البصل، لذلك نسأل المريض الذي نشك بانه مصاب بالمتلازمة إذا كانت عيناه تدمعان عند تقشير البصل ام لا.



نماذج عن الأمراض الرثويّة

☒ سنستعرض في الفقرات الآتية بعض الأمراض الرثوية التي تُصيب الإنسان:

1. اعتلال المفاصل الفقارية سلبي المصل Seronegative Spondyloarthropathy:

- مجموعة من الأمراض المفصلية، لها صفات مشتركة:
  - ✓ تصيب مفاصل معينة بالجسم: مثل المفصلين العجزيين الحرقفيين والعمود الفقري والطرفين السفليين.
  - ✓ سلبية المصل: الدم فيها لا يحوي العامل الرثياني.
  - ✓ لها استعداد وراثي متماثل.
- وتشمل: التهاب الفقار المقسط -التهاب المفاصل الصدافي -التهاب المفاصل الارتكاسي التالي للإنتانات البولية والمعوية (داء كرون) -التهاب المفاصل غير المميز -ومتلازمة رايتر.



2. النقرس Gout[25]:



لاحظ التورّم في مفصل الإبهام لمريض النقرس الناتجة عن ترسب حمض البول، انظر أيضا الصورة في الصفحة 15

- مرض حاد شائع عند 3 – 4 ٪ من البشر أي من بين كل 100 شخص هُناك 4 أشخاص مُصابين وهذه نسبة كبيرة بين البشر حيث يتظاهر بعرضين مميزين هما الألم الشديد والتورّم في مفصل الإبهام podagra، كذلك نلاحظ احمرار وحرارة.
- إذ يصيب النقرس مفاصل معيّنة بالجسم مثل المفصل السلامي المشطي الأول في القدم، لذا فإن مكان الإصابة سيوجهني لمعرفة المرض، فالنقرس لا يصيب المفاصل السنعية السلامية الأولى ولا مفاصل الرسغ.
- شائع عند الذكور كبار العمر، يساعد على تشخيص هذا المرض هو تناول المريض لأدوية الضغط التي تحرض ارتفاع حمض البول، علاجه **بالكولشيسين**.

نسبة الآلام الالتهابية التي تصيب الظهر 1 – 2 % أي أن محصلة أمراض الروماتيزم التي تصيب البشر تكون حوالي 7% = (1 – 2 % آلام ظهر + 3 – 4 % آلام نقرس) وهذه **نسبة كبيرة**.

3. الحمى الرثوية Rheumatic fever:

- مرض التهابي حاد يصيب الأطفال بعمر (5-15 سنة).
- يتطوّر بعد 2-4 أسابيع من الإنتان البلعومي بالعقديّات ويؤدي إلى ارتكاس مناعي يسبب التهاب المفاصل، في حال عدم علاجها يمكن أن تؤدي لمضاعفات قلبية، تُعالج بالبنسلينات.

ملاحظات:

- للكشف عن الحمى الرثوية نلجأ إلى اختبار آسلو ASLO كدليل على إصابة سابقة بالعقديات، وهو اختبار يكشف عن الأجسام المضادة في الدم للجراثيم العقدية.
- لا يجب إعطاء البنسلين للمرضى المتقدمين بالعمر (40 سنة فما فوق) حتى لو قاموا بإجراء اختبار آسلو وكانت نتيجته مرتفعة.

4. الداء التنكسي (الفصال العظمي أو المناقير) Osteoarthritis:

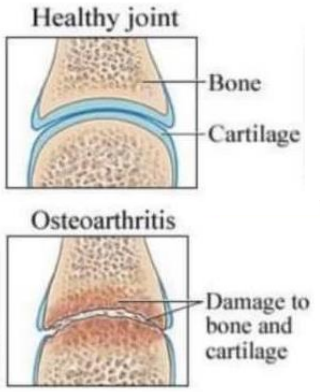
- مرض يصيب الغضروف الحامي للسطوح العظمية مما يؤدي لتسمك العظم وتشكّل ضخامة عظمية (مناقير) ومع ذلك تبقى هندسة المفصل واضحة.
- يصيب المسنين (يبدأ بعد الـ 40) والألم فيه ميكانيكي يظهر عند تطبيق جهد على المفصل.

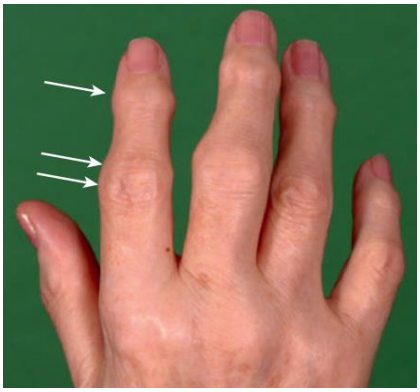
[25] تنويه: مصطلح gout يطلق على داء النقرس بشكل عام. أما podagral فهو مصطلح خاص بنقرس ابهام القدم.
حسب مرجع Tally النقرس غالباً ما يصيب إصبع القدم الأكبر بنسبة 75٪ ولكنه قد يصيب مفاصل أخرى كالكاحلين والركبتين والمرفقين وأصابع اليدين.

- ويمكن أن يظهر في أعمار مبكرة نتيجة البدانة، لذا فإن زيادة الوزن من العوامل المؤهّبة للداء التنكسي بغض النظر عن العمر.
- قد يتطور داء تنكسي ثانوي نتيجة أمراض أُخرى (مثل الرَوَح، إصابة الفخذ أو الرضفة بسبب حادث ما، أو الإصابة بالداء الرثياني بسن مبكر (18 عام مثلاً) وتكون إصابته **غير متناظرة**.

صفات الداء التنكسي

- يترافق بيبوسة صباحية لعدة دقائق
- مشوه ومحدّ لحركة المفصل
- قد تكون بمفصل واحد أو أكثر
- يصيب المفاصل الكبيرة الحاملة لثقل الجسم والمفاصل الصغيرة كثيرة العمل
- إصابة متناظرة بعد من الزمن

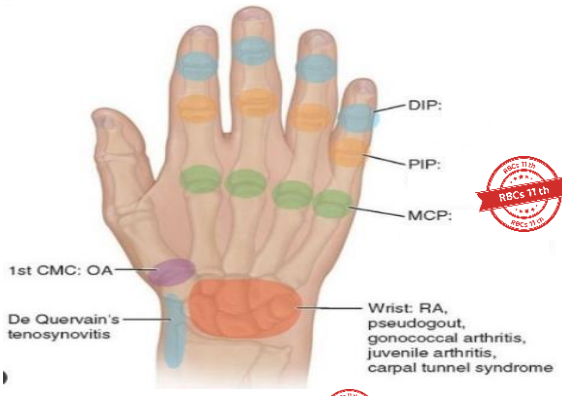




دقق مكان الأسهم في الصورة ليدّ مريض المناقير

5. الداء الروماتوئيدي أو الداء الرثياني Rheumatoid arthritis:

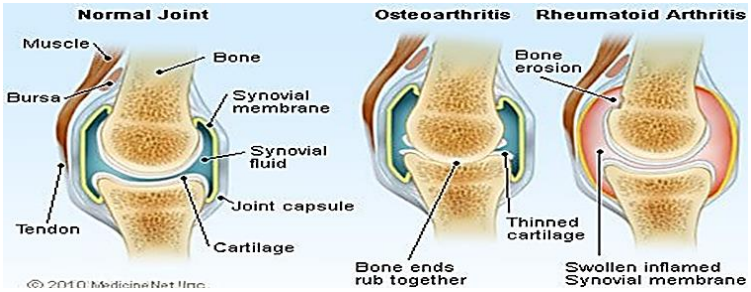
- مرض روماتيزمي مناعي ذاتي، يصيب المفاصل ذات الغشاء الزليل[26].
- يبدأ بالتهاب الغشاء الزليل ومع تقدم المرض تصاب كامل بنى المفصل وتختفي تضاريس المفصل.
- وهو التهاب عديد المفاصل يصيب المفاصل الصغيرة والكبيرة، مزمن ومتناظر، مخرّب ومشوّه يؤدي إلى عجز وظيفي للمفصل، ويترافق بتورم، عدم احمرار، حرارة ويبوسة صباحية أكثر من ساعة، كما يترافق بألم التهابي وتليف بالرئة وإصابة قلبية (مشاكل جهازية)، بالإضافة لالتهاب الصلبة والملتحمة.
- هو شائع عند الإناث أكثر من الذكور، ويصيب السيدات في منتصف العمر (35-55سنة).
- هذا مرض يصيب كل من المفاصل MCP وPIP ولا يصيب DIP[27].



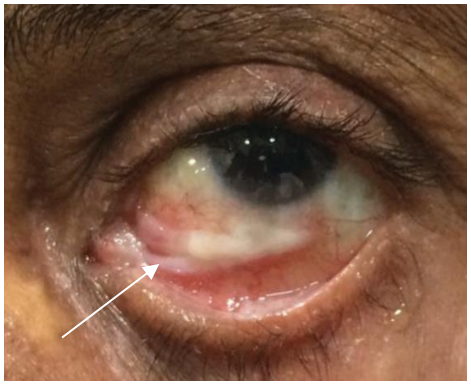
[26] وبالتالي لا يصيب المفاصل التي لا تمتلك غشاء زليل كمفاصل العمود الفقري (عدا الفقرتين الرقبيتين 1 و2).

[27] MCP: Metacarpophalangeal joints / PIP: Proximal Interphalangeal joints / DIP: Distal Interphalangeal joints

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



لاحظوا الفرق بين التهاب المفاصل الرثياني والتهاب المفاصل التنكسي

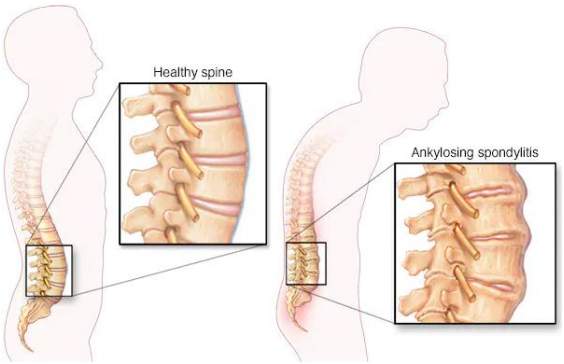


انظر التهاب الصلبة في الداء الرثياني

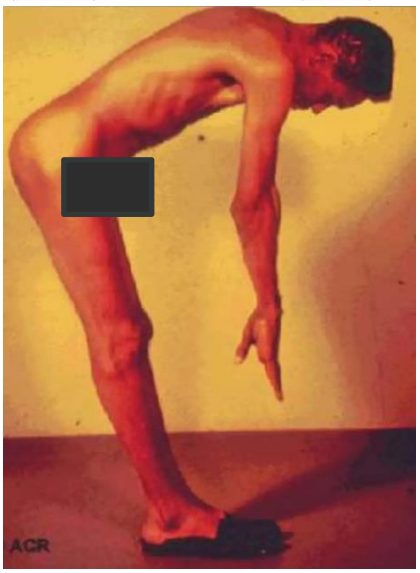


صورة توضّح تشوه المفاصل وتورمها في الداء الروماتوئيدي

6. التهاب الفقار المُقسط[28] anklyolosing spondylitis: (سلبي المصل)



- مرض مزمن يحدث فيه التهاب مفاصل العمود الفقري، فتلتحم كل الفقرات وتتصلب وتفقد مرونتها (عمود الخيزران bamboo spine) وبالتالي لا يستطيع المريض الحركة لليمين أو اليسار ولا الانحناء، يعاني من يبوسة صباحية (ما يستطيع النهوض من فراشه لبعد ساعة) آلام في العمود الفقري.
- ويمكن أن يصيب المفصلين العجزيين الحرقفيين، الوركين، الركبتين والكتفين.
- ويصيب المفاصل المحيطية بنسبة 3/1 وغالباً مفاصل الطرفين السفليين.
- تكون الإصابة من النوع قليل المفاصل غير المتناظر.
- يصيب الشباب بين 20 - 30 سنة، ونسبة إصابة الذكور أكثر من الإناث.



ملاحظة

تستخدم الماسورة للكشف عن التهاب الفقار اللاصق حيث يتميز هذا المرض بتحدد حركة العمود الفقري فيكون الظهر منحني للأمام لا يستطيع المريض رفعه وعنقهم ثابتة، ويسمى هذا الاختبار بفحص شوبر Schober's test.

[28] شائع أيضاً باسم التهاب الفقار اللاصق أو الناصب.

فيديو يوضح كيفية إجراء اختبار شوبر

7. متلازمة رايتر Reiter's Syndrome[29]:

- تشبه المقسط، إذ تصيب الفقار والمفصلين العجزيين الحرقفيين، وتكون الإصابة المحيطية فيها من النوع قليل المفاصل غير متناظر، وتستهدف الذكور.
- كلا المقسط ورايتر مجهولا السبب، ولكن الفرق بينهما أن العامل المؤهب لرايتر هو إنتان تناسلي بالكلاميديا (أي إصابة لا سيلانية نتيجة علاقات جنسية ملوثة أو بعد إنتان زحاري).

حالة سريرية

✓ **مريض يشتكي من التهاب عيني (إحمرار) مترافق مع التهاب مفصل الورك منذ أسبوعين:**

- ومن خلال اخذ القصة السريرية علمنا إنه كان مصاب بالتهاب الأمعاء.
- إن وجود التهاب أمعاء (جرثومي السبب) أدى إلى تفعيل المناعة وتشكيل الأضداد وإن بقاء هذه الأضداد في الدوران تسبب كل من التهاب العين والمفصل.

فالتشخيص هو: **داء رايتر (التهاب مفاصل إرتكاسي)**.

8. الذئبة الحمامية الجهازية Systemic lupus Erythematous (SLE):

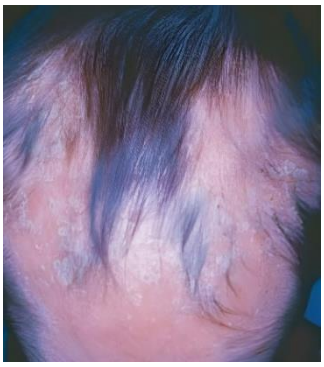


- مرض جهازي مناعي ذاتي، مهدد للحياة، يصيب السيدات بنسبة عالية 1:9 والشابات خاصةً.
- وفيها يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة النسج السليمة لذلك تترافق الذئبة مع:
  - ✓ التهاب مفاصل عديد.
  - ✓ تورم عقد لمفيّة.
  - ✓ تقرحات فموية Mouth ulcers.
  - ✓ الشعور بالتعب.
- العرض الأبرز لهذه المتلازمة هو اندفاع الفراشة malar rush الذي يتظاهر بطفح أحمر ينتشر على الوجنتين والأنف.
- من مضاعفاتها: إصابة الكليتين، القلب، الجهاز العصبي والهضمي.
- لذلك من الضروري للطبيب هنا أن يستخدم السماعة الطبية لسماع النفخات وأخذ استشارة قلبية (لأن مرض الذئبة يترافق بتظاهرات جهازية على عكس مرض النقرس مثلاً الّذي لا يحتاج لاستخدام سماعة طبية).
- وهنا يتوجه الطبيب لعلاج الأذيات الجهازية قبل المفصلية، لأن الإصابات الجهازية مهددة للحياة بينما الإصابات المفصلية هي مشوهة غير مخربة يمكن أن تتراجع عند العلاج (عكس الداء الرثياني).

[29] وهو نفسه التهاب المفاصل الارتكاسي Reactive arthritis.

9. الصداف Psoriasis:

- مرض جلدي مناعي، يترافق مع الالتهابات المفصلية الشديدة، يظهر على مرفق والركب ويتعلق بالوراثة.
- أعراضه:

ظهور لويحات حمامية متوسّفة على جلد المفصل الملتهب	ظهور قشرة بالرأس لكن ليس كل قشرة بالرأس هي صداف وسببها التهاب مفصلي	تسمك بالأظافر
		

10. متلازمة بهجت Behcet's disease:

- مرض مناعي ذاتي يترافق مع التهاب مفاصل يصنف مع أمراض التهابات الأوعية ويتعلق بالعرق والمورثات ويتظاهر بـ:
  - ✓ قلاعات فموية وقلاعات تناسلية ناكسة.
  - ✓ تظاهرات جلدية.
  - ✓ التهاب في القميص العضلي الوعائي والشبكية للعين.
  - ✓ قد تؤدي إلى خثارات بالأوردة والشرايين وصمات تؤدي إلى الوفاة.

مرض متلازمة بهجت هو مرض جهازي يصيب أجهزة الجسم مثل الذئبة الحمامية، ويختلف عنه بالتظاهرات الجلدية وكون القلاع مؤلم أم لا وللجنس المصاب به أكثر.

لاحظ بالترتيب القلاعات الفموية، القلاعات التناسلية، والتهاب القميص العضلي الوعائي للعين لدى مرضى متلازمة بهجت



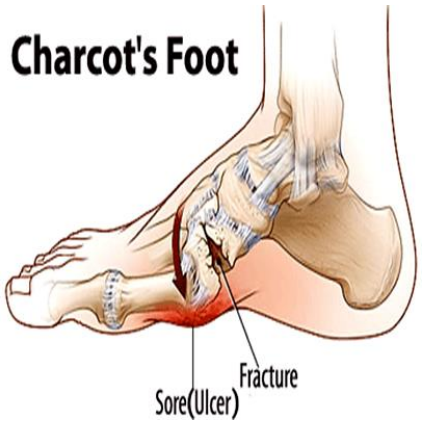
Behcet's Disease (BD)

ملاحظات:

- القلاع الفموي في الذأب الحمامي الجهازي أكثر عند الإناث ويكون غير مؤلم.
- أما قلاع داء بهجت عند الذكور يكون مؤلم جداً.
- مريض بهجت يكون رجل بعمر 20 سنة، أما مريض الذئبة الحمامية تكون أنثى بعمر 20 العام.

11. مفصل شاركو Charcot joint:

- هو اعتلال مفصلي ناجم عن اعتلال عصبي، يتميز بحدوث تشوّه ثابت في محور المفاصل.
- صفاته:
  - ✓ **الاعتلال مشوّه**: لأنه يترك عقابيل.
  - ✓ **التشوه ثابت**: لأن المريض لا يستطيع تحريك مفصله.
- أشيع أسبابه هو **داء السكري**:
  - ✓ لأن الاعتلال العصبي في داء السكري يجعل المريض يقف بوضعية غير متوازنة تسبب **ضغطاً** على المفصل المتنكّس فيتفعّل الانهدام العظمي، مما يسبب خلوع وتحت خلوع للعظام[30].



- يتغيّر محور المفاصل بسبب **الخلوع وتحت الخلوع** التي تحدث بمفصل الكاحل (وخاصّةً الأيمن) فيتغير محور المفصل (لأن جميع العظام ستتغيّر وضعيتها الطبيعية، فبعضها يخرج عن المحفظة المفصلية وبعضها يبقى داخلها مع تغيير مكانه).



لاحظ مفصل شاركو مكان السهم

- **لا يترافق مفصل شاركو مع ألم** لأن مريض السكري يعاني من اعتلال عصبي يجعله لا **يشعر بالألم** (ويجب الانتباه إلى تشخيص الإصابة بمفصل شاركو، فالبعض يظن أنه التهاب مفصل قيحي أو خرّاج فيقوم ببزله في حين أن مفصل شاركو لا يحتاج لبزل فقط تثبيت بجبيرة لمنع تطور الحالة).
- **إذاً** إنّ وجود مفصل متخرب **بدون** ألم يدل على اعتلال مفصلي عصبي المنشأ (مفصل شاركو).

الالتهاب المفصلي (Arthritis) & الألم المفصلي (Arthralgia)

- عند مقاربة المريض يجب أن نميز بين الألم المفصلي والالتهاب المفصلي.
- فالألم هو **عرض** أما الالتهاب هو **إصابة مفصلية**، أي عندما يعاني المريض من ألم في الركبة **ليس بالضرورة** أن يكون هناك التهاب، فقد يكون السبب تشنج العضلات المجاورة للمفصل.
- ويجب ملاحظة هذه الأعراض للحكم على التهاب المفصل وغير ذلك فهو ألم مفصلي (يعني لمّا ما منلاقي الأعراض السابقة).
- الألم المفصلي قد يكون ميكانيكي أو التهابي.

[30] في الخلع: يخرج الطرفان العظميان خارج التجويف المفصلي، أما تحت الخلع: يخرج جزء من الطرفيين العظميين خارج التجويف.



أسباب الالتهاب المفصلي Causes Of Arthritis

- قد تكون مناعية، انتانية، تنكسية، استقلابية (مثل النقرس الذي يسببه فرط حمض البول).
- ونحدد فيه:

1. نموذج الإصابة المفصلية.
2. متناظر أم غير متناظر.
3. يترك عقابيل أم لا.
4. مخرب ومشوّه.
5. حاد أم مزمن.
6. المهدئات والمحرضات.

1. نموذج الإصابة المفصلية:

مكان المفصل المصاب	عدد المفاصل المصابة
إصابة مفصلية محيطية	الالتهاب وحيد المفصل Monoarthritis
	الالتهاب قليل المفاصل (٥ أو أقل) Oligoarthritis
	الالتهاب عديد المفاصل (أكثر من ٥) polyarthritis
إصابة مفصلية محورية	التهاب الفقار
	التهاب المفصلين العجزيين الحرقفيين

2. الالتهاب المفصلي (متناظر أم غير متناظر):

- الالتهاب **قليل** المفاصل غالباً يكون **غير متناظر** مثل: التهاب الفقار المقسط وداء رايتر.
- الالتهاب **عديد** المفاصل غالباً يكون **متناظر** مثل: الداء الرثياني.

حالة سريرية (سؤال فحص):

- سيدة عمرها 45 سنة لديها ألم وتورم في المفاصل السنعية السلامية أو بين السلامية الدانية مع يبوسة صباحية أكثر من ساعة، فالتشخيص الأكثر احتمالاً هو **الداء الرثياني**.

3. الالتهاب المفصلي الذي يُشفى بلا عقابيل (أذيّات بعد الشّفاء):

- وهنا تكون الإصابة المفصلية غير مخربة وغير مشوهة وتتراجع بانحسار هجمة المرض، مثل:
  - الحمى الرثوية - داء بهجت - الذئبة الحمامية، أما **التهاب المفاصل الرثياني يترك عقابيل**.

4. التهابات المفاصل المخربة (تخرّب السطوح المفصليّة):

- التهاب المفاصل الرثياني.
- اعتلال المفاصل عصبية المنشأ (مفصل شاركو).
- اعتلال المفاصل سلبية المصل (الفقار المقسط، رايتر، الصداف).
- النقرس المزمن.
- التهاب المفاصل الانتاني.

حاله سريرية (سؤال فحص):

- مريض لديه اعتلال عصبي، ومفصل مخرب ومتورّم ولكن لا يؤلمه مفصل شاركو.
- التشخيص السريع للالتهاب المفصل القيحي ينقذ المريض من التخريب المفصلي، فخلال **أسبوعين** من الالتهاب القيحي **يفقد المفصل وظيفته ويتخرب**.

حالة سريرية (سؤال فحص):

- فتاة عمرها 25 سنة، تعاني من ألم ركبة مفاجئ منذ يومين مع تورم واحمرار وحرارة موضعية على جلد المفصل وحرارة عامة 40 ⬅ التهاب مفصل قيحي.

ولكن لماذا لم نختار النقرس رغم أن له نفس علامات التهاب المفصل القيحي وكلاهما حاد؟

نفرق بين التهاب المفاصل القيحي والنقرس بناءً على النقاط التالية:

1. **العمر:** النقرس يصيب الذكور فوق الـ 40 – 50 سنة بنسبة أكبر من الإناث.
2. **مكان الإصابة:** النقرس يصيب مفصل إبهام القدم بينما المفصل القيحي يصيب الركبة أو الورك كما في العنقودية المذهبة.
3. **الحرارة العامة:** وهي أمر هام جداً، فعندما تكون الحرارة العامة 40 فالحالة **التهاب مفصل قيحي حكماً**، أما النقرس فيمكن أن تصل الحرارة العامة لـ 38.

الإصابة الحادة Acute والإصابة المزمنة Chronic:

♥ يعتمد التفريق بين الإصابة المفصلية الحادة والمزمنة على **مدة كلٍّ منهما**، حيث يوجد معايير مُعتمدة في هذا السياق، ومنها:

حسب معايير الروماتيزم	حسب معايير التشريح المرضي
✓ الإصابة **الحادة**: **أقل** من 6 أسابيع. ✓ الإصابة **المزمنة**: **أكثر** من 6 أسابيع.	✓ أقل من أسبوعين تكون الإصابة **حادة**. ✓ من 2-6 أسابيع تكون الإصابة **تحت حادة**. ✓ أكثر من 6 أسابيع تكون الإصابة **مزمنة**.

ملاحظة

✓ الإصابة الحادة للمفصل تكون بسبب:
- خمج Infection أو رض Trauma (سبّب أذية وعائية) أو هجمة حادة للنقرس.

✓ الإصابة المزمنة للمفصل تكون بسبب:
- سرطان أو أمراض مناعة ذاتية.



لما لا نجرب الآن إعطاء التشخيص الأولي للحالة السريرية القادمة

- جاءت مريضة بعمر 62 عام إلى العيادة تشكو من ألم مفاصل في يدها مرتبط بالحركة مع يبوسة صباحية تمتد بين 10 إلى 15 دقيقة، الألم بدأ حديثا حيث أصبح يعيق أنشطتها، الفحص السريري أظهر مفاصل يديها بالشكل الأتي:



ما هو التشخيص المبدئي؟

A. نقرس Gout
B. التهاب مفاصل ارتكاسي Reactive arthritis.
C. فصال عظمي Osteoarthritis.
D. داء رثياني Rheumatoid arthritis.

الجواب C.

هاقد وصلنا إلى ختام محاضرتنا

لاتنسونا من دعائكم

دوّن ملاحظاتك